

的原因不清楚。尿毒症狗服用25 (OH) D后,血清1, 25 (OH)₂D显著增加,而血清PTH、离子钙和磷却无变化,说明这种增加仅是用25 (OH) D后引起的作用;无肾病人口服25 (OH) D后,血清1, 25 (OH)₂D同样显著增加,说明这种增加也并非仅仅是增加残留肾的1-α-羟化酶底物利用度的作用。本文支持肾外存在有羟化胆钙化醇1-α位置产生1, 25 (OH)₂D (即钙三醇)能力的观点,但人在无肾时,只有当25 (OH) D超过生理浓度时,这种能力才表现出调节血清1, 25 (OH)₂D浓度到接近正常浓度的作用。

〔刘宁摘 伍志刚校〕

128 系统性红斑狼疮高钾血症的机理〔英〕/ Lee FO... // Arch Inter Med. —1988, 148:397~401

作者们发现,约10%的SLE伴持续性高钾血症,其机理尚未阐明。本文从142例符合美国风湿病协会SLE分类标准筛选5例SLE伴合钾血症 (两次随机非溶血标本血清钾 ≥ 5 mmol/L)且原因不明者,和SLE血钾正常者5例对照,前者为第1组,后者为第2组,两组肾功能相似。全部受检者均无活动性狼疮肾炎,无引起高钾血症的其它原因,如严重肾功能衰竭、溶血、假性高血钾、Addison氏病、酸中毒等因素,一周前均停用非类固醇抗炎药 (NSAIDs) 或皮质激素。

作者们对两组患者研究了对静脉注射速尿 (60mg) 和直立位的肾素-醛固酮应答及对转换酶抑制剂 (疏甲丙脯酸50mg) 和直立位的肾素应答。

SLE伴高钾血症患者均有肾脏排钾障碍,通常认为醛固酮缺乏是不少尿型肾性高钾血症的主要原因,醛固酮缺乏常继发于低肾素性低醛固酮综合征所致肾素产生障碍;此外远端小管对盐皮质激素无反应也引起肾性高钾血症。本资料第1组SLE病人血浆氯离子水平高于第2组病人,血浆碳酸氢根离子水平略低于第2组病人。两组病人血浆氢化可的松水平正常,血浆肾素浓度基础水平和血浆醛固酮水平均无显著性差异,但第2组所检测指标偏高。第1组5例SLE病人中4例肾素对疏甲丙脯酸反应较第2组病人显著减弱,且肾素和醛固酮对速尿反应也较第2组病人减弱。提示大多数SLE伴高钾血症病人的肾素和醛固酮对刺激反应减弱;低肾素血症、低醛固酮血症是SLE伴高钾血症发病机制的重要原因之一。SLE伴高钾血症肾素缺

乏的原因尚不清楚,目前证明扩张血管的前列环素是肾素释放的主要介导体,如服用NSAIDs可抑制前列腺素合成导致肾素缺乏。作者认为前列腺素生成障碍在低肾素性低醛固酮血症发病机制中起关键作用;产生肾素的近球细胞的直接损害也可引起肾素缺乏。

盐皮质激素或/和速尿能纠正慢性低肾素性低醛固酮血症的高钾血症性肾小管酸中毒。

〔樊均明摘 许国章校〕

129 常规服用止痛合剂与末期肾衰的危险性〔英〕/ Pommer W... // Lancet. —1989, I (8634) : —381

定期服用止痛剂与末期肾衰因果关系的流行病学资料甚少,并且有的尚有争论。Murray等的对照研究未能证实其相对危险性 (RR) 的明显增加。作者们对止痛剂的研究结果与之相反。

作者们对多中心设有对照组的病例进行了回顾性研究,调查对象为1984~1986在西柏林进行长期透析的肾病患者921例。按性别、年龄及国籍配对选择对照组。访问时记录毕生服止痛剂史。定期服止痛剂的标准为每月服15次以上止痛剂、(包括片剂、水剂及栓剂)至少持续1年。止痛剂的成分为非那西汀、扑热息痛、阿斯匹林、安乃近、氨替比林及咖啡因。

调查结果表明长期服用止痛合剂后,末期肾衰RR明显增高,RR且随剂量及摄入时间而增加。单一成分的止痛剂不增加RR。每月服止痛剂小于60次至少5年者,导致2.03 (95%置信区间 [CI] 1.37~2.97) 的RR,而多于60次者其RR增至4.83 (95%CI 2.70~8.76)。

作者的结论是,较以前使用量为小、时间为短的止痛合剂定期使用,可导致末期肾衰的危险性增高,因此这种合剂应禁止使用。本研究结果及其他资料提示,在止痛合剂中以扑热息痛取代非那西汀并不足以防止止痛剂所致的肾损害。

〔李春元摘 李梓校〕

130 环孢素的药物相互作用〔英〕/ Cutler RE... // Dial & Transp. —1988, 17 (3) : 139

当环孢素 (Cs) 同时与其它肾毒性药物并用时可产生相互作用,使Cs的血浓度改变或产生毒性作用。Cs—药物间相互作用的可能机理主要影响肠道淋巴流和胆汁流、脂蛋白结合力、肝脏代谢

途径、肝脏细胞色素CP—450氧化、肾小管和肾血管。口服Cs后，血浆浓度峰值在1~8小时，但并不完全与剂量有关。生物利用度约为30%，但在肝病、肠道疾病或移植后早期者可<10%，胆汁是吸收所需要的。动物试验提示，Cs由肝脏单氧合酶系统代谢，其清除途径为肝脏代谢和排泄，胆汁中同时有Cs的代谢物和未变化的药物，其血浆清除率有很大差异，似乎受移植类型、年龄、疾病状态和并用药物的影响，健康人RIA法平均血浆半衰期为8.4小时，Hplc法为6.3小时，肝病患者显著延长，RIA法为24小时，Hplc法为20小时。Cs在人和动物的主要排泄途径为胆道，胆汁中的药物浓度总比同时的血液度高，而肾脏排泄很少，不到给药量的1%。Kahan等人用RIA法提示Cs有极少量的肝肠再循环。

升高Cs血液浓度的药物：酮康唑和红霉素恒定地增加Cs的血浓度，其机理是使细胞色素P—450减少或其它的肝酶抑制，Cs的分布容量缩小或增加血浆蛋白结合率，其中氧化代谢受抑为主要原因。甲基强的松龙：大剂量（≥250mg/d）增加Cs的血浆浓度，已知皮质类固醇是肝脏药物代谢的诱导剂，因此文献报道提示是使Cs的分布容量有某些变化或异常动力学改变。Ptachcinski等人证明，大剂量强的松龙可能诱导Cs和其非极性代谢物的代谢而抑制Cs极性代谢物的排泄而改变其分布容量，但未发现导致Cs中毒或肾移植排斥的报告。钙通道阻滞剂：硫氮草酮和硝吡啶甲脂可使Cs血浓度升高，前者是降低Cs的血浆清除率，且有报告具有肾毒性。异搏定或硝苯吡啶尚未发现有不利的相互作用，一些学者认为，硫苯吡啶显著的扩血管作用可能实际上改善Cs的肾毒性。Dieperink等人在动物实验发现，硝苯吡啶对Cs的肾毒性有部分保护作用。雄激素/雌激素：由于类固醇是肝脏微粒体酶的弱抑制剂，因而可能干扰Cs的代谢，但具体机理不清。

降低Cs血液浓度的药物：苯妥英钠、苯巴比妥、酰胺咪嗪和利福平通过增加肝脏微粒体代谢使Cs的血浓度降低。SMZ—TMP降低Cs的血浓度，可导致肾移植排斥。Ryffel等人动物实验发现，前列腺素E₂类似药与Cs的相互作用发生在肠道吸收界面，减少Cs的吸收。

药效学的相互作用：Cs与其它已知的肾毒性药物不利的相互作用已有记载，包括氨基甙类、二性霉素B、左旋溶肉瘤素、TMP、复方新诺明、非类固醇抗炎药。速尿和甘露醇在动物可增加肾毒

性，但未见在人类的类似报告。目前使用多种药物作为移植的免疫抑制的倾向可能使感染和恶性变增加，但只有仔细观察才能估计这些相互作用的重要性和发病率。此外，个案报告同时使用甲基强的松龙导致癫痫发作；当发生Cs肾毒性时产生地高辛中毒；粪链球菌性尿路毒症使用Imipenem/或Cilastatin时可使Cs血液升高并产生神经毒性。

〔胡家胜 摘 田盛玉 校〕

131 尿路念珠菌病〔英〕/Editorials//Lancet —1988, II (8618) . —1000~1002

念珠菌肾盂肾炎可发于成人、儿童及新生儿，通常是它处感染灶或从胃肠共栖场所的白色念珠菌血源性播散的结果。上尿路的上行性感染少见，存在于体内的血管导管及使用产谱抗菌药物是新生儿肾念珠菌病的重要感染因素，在许多病例中，肾感染导致菌丝体凝块（真菌球）形成，可引起肾盂及输尿管梗阻而致肾盂积水或无尿。

下尿路念珠菌病（膀胱炎）通常是由上行感染所引起，有的病例有糖尿病且大多数有尿路异常或损害。大多数感染与内在尿道导管和/或使用抗菌药物有关，临床表现不一，持续时间可很短暂或持久，预后可很好或不良。多数病例仅限于下尿路，但危重病例偶可发生肾或播散性感染。

两次尿标本中菌落数>10⁵/ml为诊断下尿路感染的良好指标。有临床意义的念珠菌尿尚无统一诊断标准，有些人似乎认为真菌菌落>10³/ml才有意义，而有的人认为菌落数<10⁵/ml无意义，而Kozinn等发现导尿或中段尿中菌落数>10⁴/ml可预示为肾感染，但这一标准不适用于长期留置导尿管患者的尿培养，因这些病例菌落数增多只表明下尿路或导尿管中细菌无损害性移居，对非留置导尿管的病例应避免阴道或会阴感染污染标本，婴儿以从耻骨弓上收集尿液为最好。

虽然肾念珠菌感染患者较膀胱炎易出现不适、发热及寒战，但这些表现未必表明为严重感染。少尿及无尿为婴儿肾念珠菌病常见表现，成人或婴儿除肾盂及输尿管有真菌球表现为可透X线的、不规则的充盈缺损外，无鉴别性X线体征。不论感染部位如何，尿沉淀中通常含有红细胞与白细胞以及白色念珠菌的酵母菌与菌丝形式。通过检测包被IgG白色念珠菌细胞以观察细菌性感染无助于鉴别肾盂肾炎及膀胱炎，然而亦有人认为血清学监测有助于区别肾念珠菌病与下尿路感染，但有人认为此种方